

TEMA 3.6 • OBSTETRICIA

Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo

PERFIL EUNACOM 2.01.2.005
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo

Metas Metabólicas (más estrictas que en no-embarazadas)

TABLA 3.6.1: MOMENTO VS META GLICÉMICA	
MOMENTO	META GLICÉMICA
Preprandial (antes de comidas)	< 90 mg/dL
Postprandial (después de comidas)	< 120 mg/dL

NOTA CLÍNICA

El control es con **hemoglucotest domiciliario**, 4 veces al día. Cada 2 semanas la paciente presenta su cartilla de glicemias para ajustar tratamiento.

La **HbA1c** no es útil como guía de tratamiento en el embarazo (se demora mucho en cambiar vs. duración del embarazo), aunque puede pedirse cada 6–8 semanas como referencia objetiva.

Tratamiento Farmacológico

Insulina (primera línea)

TABLA 3.6.2: INSULINA VS INDICACIÓN	
INSULINA	INDICACIÓN
NPH	1ª línea — 1 o 2 dosis al día. Seguridad bien establecida en embarazo
Cristalina (regular)	Se agrega si control con NPH no es óptimo
Análogos ultralentos (glargina)	Evitar en embarazo — perfil de seguridad no completamente aclarado
Análogos ultrarápidos	Menos estudiados, aunque evidencia disponible sugiere seguridad

Hipoglicemiantes orales

TABLA 3.6.3: FÁRMACO VS SEGURIDAD EN EMBARAZO	
FÁRMACO	SEGURIDAD EN EMBARAZO
Metformina	Segura — puede mantenerse o iniciarse
Glibenclamida (gliburida)	Segura — puede mantenerse o iniciarse
Otros	No recomendados en embarazo

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En la práctica, las guías recomiendan **preferir insulina** en el embarazo, aunque metformina y glibenclamida son opciones válidas. Decisión caso a caso con la paciente.

Manejo de la Mujer Diabética que Quiere Embarazarse

- **Optimizar control glicémico antes** del embarazo → meta: HbA1c < 7%
- Idealmente ya con insulina al momento de embarazarse
- **No embarazarse con mal control** (riesgo de malformaciones en primer trimestre)

Manejo en el Parto

- El parto genera **estrés metabólico** → riesgo de hiper o hipoglicemia (más frecuente hiperglicemia)
- Control con hemoglucotest **frecuente** durante el trabajo de parto
- Puede requerirse insulina cristalina EV según valores
- En muchos casos el útero consume suficiente glucosa y no se requiere insulina adicional

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo: Momento | Meta glicémica | |---|---| | Preprandial (antes de comidas) | < 90 mg/... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Metas Metabólicas (más estrictas que en no-embarazadas)
- Tratamiento Farmacológico
- Insulina (primera línea)
- Hipoglicemiantes orales
- Manejo de la Mujer Diabética que Quiere Embarazarse
- Manejo en el Parto
- Preprandial (antes de comidas)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN EL EMBARAZO)

PREGUNTA 1

En relación a Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo: Momento | Meta glicémica | |---|---| | Preprandial (antes de comidas) | < 90 mg/...
¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN EL EMBARAZO

:::note El control es con hemoglucotest domiciliario, 4 veces al día. Cada 2 semanas la paciente presenta su cartilla de glicemias para ajustar tratamiento. La HbA1c no es útil como guía de tratamiento en el embarazo (se demora mucho en cambiar vs. duración del embarazo), aunque puede pedirse cada 6–8 semanas como referencia objetiva. :::
:::warning En la práctica, las guías recomiendan preferir insulina en el embarazo, aunque metformina y glibenclamida son opciones válidas. Decisión caso a caso con la paciente. :::